SDD 71 Sujet n°1

Spécialité : Rhumatologie

Date : 25/09/2023
Auteur : RAVEL Anaïs (DES Psychiatrie)
Relecteur(s) : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie), Service de rhumatologie du CHU de Bordeaux

Domaine d'apprentissage principal	Examen clinique
Domaine d'apprentissage secondaire	Interrogatoire
Item(s) en lien avec la station	ITEM 93 Syndrome de la queue de cheval ITEM 94 Rachialgie ITEM 95 Radiculalgie et syndrome canalaire
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 71 Douleur d'un membre
Matériel nécessaire à la station	- Un marteau réflexe - 2 chaises - un bureau
Contexte de la station	- Le/La candidat.e reçoit Monsieur Longe, qui il y a 3 jours, a commencé sa journée de travail en soulevant un réfrigérateur. C'est à ce moment-là que la douleur s'est déclenchée, comme s'il s'était pris la foudre. La douleur est localisée à droite et dans le bas du dos.

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste en campagne.
Vous recevez Monsieur L, 43 ans, au cabinet, qui présente une douleur du membre inférieur droit.

Monsieur L est déménageur. Il y a 3 jours, il a commencé sa journée en soulevant un réfrigérateur, déclenchant une vive douleur dans le bas du dos et le membre inférieur droit. Il décrit cette douleur comme s'il s'était « pris la foudre dans la jambe ». Devant ce tableau, vous suspectez une lomboradiculalgie.

Monsieur L n'a aucun antécédent familiaux, aucun traitement de fond, ni allergie connue.

Consignes :
Vous devez réaliser en 7 minutes /annoncer/prescrire :

- Poursuivre l'interrogatoire ciblé sur la douleur
- Rechercher à l'interrogatoire et l'examen clinique les éléments ciblés à rechercher (le/la patient.e simulé.e restera habillé.e)

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
Rubrique 1 : Interrogatoire de la douleur			
1.	Demande ce qui calme ET majore la douleur	1 pt	☐
2.	Demande le trajet de la douleur	1 pt	☐
3.	Recherche une hyperalgie résistante aux traitements antalgiques (demande les 2 éléments) : ● Demande l'intensité de la douleur via une EVA ou une autres échelles d'évaluation de la douleur ● Demande si à pris des traitement ET leur effet sur la douleur	1 pt	☐
4.	Demande l'horaire où se manifeste la douleur/ où la douleur est maximale ET s'il y a des réveils nocturnes douloureux la nuit	1 pt	☐
Rubrique 2 : Recherche des signes urgent			
5.	Recherche un déficit moteur avec un testing moteur du territoire S1 (limitation de la marche sur la pointe des pieds ou testing moteur couché des jambes)	1 pt	☐
6.	Recherche des troubles génito-sphinctériens (au moins 2 éléments demandés/faits parmi les suivants) : ● Demande si le patient constate une perte de sensibilité durant le passage des selles ou des urines ● Demande si le patient est incontinent ou présente une rétention d'urine ● Demande si le patient présente des troubles érectiles ● Dit faire un examen de la sensibilité du périnée	1pt	☐
7.	Recherche d'un signe d'irritation pyramidal au pied (signe de babinski : touche la plante du pied au niveau/ un peu au-dessus du talon et remonte le long du bord externe de la plante du pied, puis remonter vers la base de l'hallux)	1 pt	☐
Rubrique 3 : Signes de gravité			
8.	Recherche à l'interrogatoire une altération générale (recherche au moins 3 de ces 4 signes) : ● Perte de poids récente ● Baisse de l'appétit/de la prise alimentaire ● Asthénie (fatigue) ● Fièvre	1pt	☐

<table>
<tr><td>9.</td><td>Recherche dans les antécédents personnels (doit demander précisément les 2 pour avoir le point) :
● Un cancer
● Geste invasif récent</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rubrique 4 : Examen clinique</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Recherche une raideur au niveau lombaire via la pratique d’inflexion latéral (demande au patient de basculer son buste sur le côté droit, puis gauche)</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Pratique la manœuvre de Lasègue du côté homolatéral à la douleur (Couche le patient, puis élève sa jambe, la cuisse en flexion, en gardant le genou en extension. Recherche une majoration de la douleur)</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Pratique la manoeuvre de Lasègue du côté controlatéral (à la recherche d’un signe de Lasègue croisé)</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Recherche une perte de sensibilité sur le métamère S1 (au toucher)</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Recherche une abolition du réflexe calcanéen fait couché

Image issue du site Slideplayer</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="4">Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>2. APTITUDE À QUESTIONNER
<table>
<tr><th>Performance Insuffisante

0 point</th><th>Performance Limite

0,25 point</th><th>Performance Satisfaisante

0,5 point</th><th>Performance Très Satisfaisante

0,75 point</th><th>Performance Remarquable

1 point</th></tr>
<tr><td>Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs

Utilise le jargon médical</td><td>Pose des questions qui s’éloignent des objectifs

Utilise quelques fois un jargon médical sans explication</td><td>Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels

Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications</td><td>Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures

Utilise le langage approprié</td><td>Pose les questions avec assurance et savoir-faire</td></tr>
</table></td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>2.</td><td>

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

<table>
<tr><th>Performance Insuffisante
0 point</th><th>Performance Limite
0,25 point</th><th>Performance Satisfaisante
0,5 point</th><th>Performance Très Satisfaisante
0,75 point</th><th>Performance Remarquable
1 point</th></tr>
<tr><td>L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique</td><td>Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles</td><td>L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels</td><td>L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile</td><td>L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée</td></tr>
</table>

</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>

10. APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE

<table>
<tr><th>Performance Insuffisante
0 point</th><th>Performance Limite
0,25 point</th><th>Performance Satisfaisante
0,5 point</th><th>Performance Très Satisfaisante
0,75 point</th><th>Performance Remarquable
1 point</th></tr>
<tr><td>N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient</td><td>Explique peu les gestes réalisés</td><td>Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient</td><td>Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient</td><td>Agit sans erreur
Met à l'aise</td></tr>
</table>

</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL (max 20 items)</td><td colspan="2">…/17 points</td></tr>
</table>

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

- Signes urgents = nécessite une prise en charge rapide
- Signes grave = évoque une possible étiologie grave (cancer notamment)

Concernant le signe de la Sonnette (percussion vertébrale) : Bien que cité en effet dans votre cours, et possible de le faire dans l'examen clinique, les rhumatologues de Bordeaux explique que cette manoeuvre n'a que peu d'intérêt car apporte peu d'information à la prise en charge

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

- Le/La candidat.e reçoit Monsieur Longe, qui il y a 3 jours, a commencé sa journée de travail en soulevant un réfrigérateur. C'est à ce moment-là que la douleur s'est déclenchée, comme s'il s'était pris la foudre. La douleur est localisée à droite et dans le bas du dos.

Plan de la station ECOS :

Patient restera debout, de l'autre côté du bureau
Nécessite d'avoir au moins un tabouret/une chaise

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

- "Bonjour docteur, j'ai vraiment très très mal à la jambe droite et au bas du dos là"

Identité du patient :

Stanislas Longe
43 ans, Homme
1m85, 75kg

Mode de vie :

- Déménageur
- Célibataire, pas d'enfant
- Pas de consommation d'alcool, tabac ou drogue
- Pas d'allergie
- Pratique le tennis

Comportement global :

- Douloureux, ne veut pas s'asseoir
- Inquiet

Antécédents personnels :

Pas d'antécédent personnel

Antécédents familiaux :

Pas d'antécédent familiaux

Médicaments :

- Paracétamol 1 gramme, plusieurs prises

Symptômes positifs d'interrogatoire:

- Si le/la candidat.e demande de vous asseoir : « Impossible ! Je suis bien mieux debout. »
- Si questionne sur le trajet de la douleur : "La douleur part du bas du dos jusqu'au dernier orteil en passant par l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet et la plante du pied" (Pour vous représenter : trajet S1, en vert sur le schéma).

- Si demande ce que la douleur augmente : “Elle est maximale pendant que je fais un effort, mais aussi quand je suis assis”.
- Si demande l’horaire de la douleur/ quand la douleur est la plus forte dans la journée :” Le soir surtout”
- Si demande s’il y a un dérouillage le matin en se levant : Non pas vraiment, le matin ça va”
- Si demande si cela réveil la nuit : “Non je dors bien”.
- Si demande ce qui soulage la douleur : “La seule position qui le soulage est la position allongée”.
- Si demande l’intensité de la douleur : “C’est insupportable vraiment”
- Si demande de côté la douleur de 0 à 10 : “ C’est un bon 7/10 là”
- Si demande le type de douleur : “Cela me brûle, avec parfois des décharges comme de l’électricité”
- Si demande si la douleur est majoré à la marche ou si cela affecte la marche : “Non non marché ça va, mais m’asseoir, impossible”
- Si demande si vous avez pris des médicaments : “Oui du PARACÉTAMOL, 1 gramme je crois, ça calme la douleur mais pas longtemps”
- Si demande l’intensité de la douleur de 0 à 10 avec la prise de PARACÉTAMOL : “Cela descend à 2/10”
- Si demande si la douleur est augmenté à la toux : “Oui en effet”

Si vous demande les signes suivants, répondre : “Non je n’ai pas ça”
- Pas de perte de force
- Pas de perte de sensibilité
- Pas de sensation bizarre (type fourmillement, engourdissement, etc.)
- Pas d’incontinence urinaire ou fécale
- Pas de blocage pour uriner ou pour évacuer les selles
- Pas de trouble érectile
- Pas de perte des sensations anal ou génital lors de la défécation ou lorsqu’urine (sent bien le passage des selles et de l’urine)
- Pas de fatigue
- Pas de perte de poids récente
- Pas de perte d’appétit/de diminution des repas
- Pas de fièvre récente
- PAs d’antécédent personnel de Cancer et de geste invasif

Symptômes positifs d'examen clinique (tout examen réalisé par le candidat médecin qui n'apparaît pas dans ce tableau devra donner lieu à une réaction normale) :

Si le candidat médecin fait :	Comment réagir :
Appuyer sur les vertèbres le long de la colonne vertébrale…	…manifester des signes de douleur quand le candidat arrive tout en bas du dos.
Demander de toucher le sol en position debout…	…ne pas réussir à descendre plus bas que les genoux et manifester que c'est à cause de la douleur. Préciser « d'habitude je suis quand même un peu plus souple que ça ».
Lever la jambe droite en étant allongé sur le dos…	…manifester une vive douleur dans cette jambe (sur le trajet du schéma plus haut) dès que le talon s'éloigne de plus de 30-40cm de la table d'examen.
Lever la jambe gauche en étant allongé sur le dos…	…manifester une vive douleur dans la jambe droite (sur le trajet du schéma plus haut) dès que le talon gauche dépasse les 50-60cm de la table d'examen.
Demander de marcher sur la pointe des pieds ou sur les talons…	…le faire normalement.
Tester les réflexes avec un marteau réflexe…	…pas possible de le mimer donc dire « ça ne fait rien, le pied ne bouge pas » pour le réflexe du talon (mais tous les autres sont normaux).
Si recherche un signe de Babinski (stimule la plante du pied le long du bord externe, puis revient vers la base du gros orteil).	… Dire que cela ne fait rien au niveau du gros doigt de pied

Questions de relance :

- Si les réflexes n'ont pas été testés : « à quoi ça sert ? » (en désignant le marteau réflexe à disposition du candidat)
- Si le candidat n'a pas parlé des éléments de gravité (les éléments de l'interrogatoire qui ne sont pas censé être présent, voire la partie signe positif interrogatoire), demander : « est-ce que c'est grave du coup ? »

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Patient debout de l'autre côté du bureau

Matériel nécessaire à la station :

- *IPAD pour examinateur*
- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*
- *Un marteau réflexe sur la table*

Documents présents dans la station :

- *Feuilles d'évaluation de papier de secours*